

- [28]吴文明,赵佳欣,张艳.“双心”疾病辨证治疗[J].实用中医内科杂志,2012,26(2):35—36.
- [29]Vogelzangs N, Seldenrijk A, Beekman A T F, et al. Cardiovascular disease in persons with depressive and anxiety disorders [J]. Journal of affective disorders, 2010, 125(1—3): 241—248.
- [30]邢科,安冬青.冠心病合并失眠的中医药临床研究进展[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(76):63—65.
- [31]胡林强,陈联发.冠心病患者“双心医学”中医药治疗研究进展[J].中医药通报,2019,18(1):70—72.
- [32]张杰,鞠建庆,张艳,等.冠心病“双心”异常的中医治疗研究进展[J].中西医结合心脑血管病杂志,2019,17(9):1329—1331.

中医药治疗脾肾阳虚型肾病综合征的研究进展

周婵 王铁良*

(黑龙江省中医药科学院 黑龙江 哈尔滨 150000)

[摘要] 肾病综合征是多种原因导致的肾小球疾病,临床多见且治疗复杂,西医治疗局限于激素等药物,但激素不适合长期使用,而中医药在治疗肾病综合征方面,不仅能减轻症状、延缓病情、促进肾功能恢复,而且能在一定程度上消除激素的副作用,具有较好的临床效果。肾病综合征最常见的证型为脾肾阳虚证,本文对脾肾阳虚型肾病综合征的中医药治疗进展进行研究,以期肾病综合征研究提供更多的临床思路,力求共同进步,为广大患者带来福音。

[关键词] 肾病综合征;病因病机;脾肾阳虚型;中医治疗

中图分类号:R692

文献标识码:B

文章编号:1006-0979(2023)03-0083-03

Research progress of traditional Chinese medicine in the treatment of spleen and kidney yang deficiency type nephrotic syndrome

ZHOU Chan, WANG Tie-liang

(Heilongjiang Academy of Chinese Medicine, Heilongjiang Province, Harbin 150000, China)

[Abstract] Nephrotic syndrome is a glomerular disease caused by a variety of reasons. It is common in clinical practice and complicated in treatment. Western medicine treatment is limited to hormones and other drugs, but hormones are not suitable for long-term use. In the treatment of nephrotic syndrome, traditional Chinese medicine not only can Relieve symptoms, delay the disease, promote the recovery of renal function, and can eliminate the side effects of hormones to a certain extent, with good clinical effects. The most common syndrome of nephrotic syndrome is spleen-kidney yang deficiency syndrome. Therefore, this paper studies the progress of traditional Chinese medicine treatment of spleen-kidney yang deficiency nephrotic syndrome, in order to provide more clinical ideas for related research on nephrotic syndrome, and strive to Make progress together and bring the gospel to the majority of patients.

[Keywords] Nephrotic syndrome; etiology and pathogenesis; spleen-kidney yang deficiency type; traditional Chinese medicine treatment

DOI:10.16040/j.cnki.cn15-1101.2023.03.019

肾病综合征(NS)是不同原因所致的大量蛋白尿、低白蛋白血症、高度水肿和(或)高脂血症的临床综合征,且可引起感染、血栓等一系列并发症,甚至导致终末期肾脏病。现代医学以激素和免疫抑制等治疗为主,但其严重的不良反应在临床上运用多有限制。因此,当代医者为探究如何提高疗效、降低不良反应发生率做出了许多努力,中医在治疗肾病综合征方面有着无可替代的优势,近几年来医者通过研究经典文书,且结合现代医学不断实践,在临床方面取得了良好的效果。既往学者通过大量研究,指出全国脾肾阳虚型患者占NS患者的比例为40.33%,认为脾肾阳虚型是肾病综合征关键病机^[1]。因此,本文就中医药治疗脾肾阳虚型肾病综合征的研究进展综述如下。

1 病因病机研究

肾病综合征在中医中没有病名,根据症状可以归属为“水肿”“尿浊”“腰痛”“虚劳”等范畴。水肿为肾病综合征典型症状,尿蛋白排出超过正常负荷及白蛋白的大量流失都是造成水肿

的基本原因。《黄帝内经》对“水”病因的阐述有劳汗当风、邪侵玄府、饮食失节等。而《素问·水热穴论》云:“肾,胃之关也”,高度概括了脾、胃、肾与水肿关系。《素问·经脉别论》曰:“饮入于胃,游溢精气……揆度以为常也”,即人体水液源于胃的受纳水谷,经过脾的运化至肺,然后布达全身,最后由肾代谢。水液输布与代谢依赖肺、脾、肾三脏,说明肺、脾、肾功能失常就会形成水肿。严用和在《济生方》中将水肿论阴阳。他认为阴水发病来势缓慢,面色㿔白,小便量少色青,大便稀溏,一派阳虚的表现;阳水则发病迅疾,面色红赤,烦躁,口渴,小便色红,大便结,以实证为主。一虚一实,奠定了水肿临床辨证的基础。严用和倡导水肿多为虚证,且与脾肾两虚有关,提出温脾暖肾的治法,与前人不同,开创了补法,设立实脾饮。国医大师郑新^[2]提出“肾病三因论”(1.肾主水、藏精,其本在肾;2.脾主运化,其制在脾;3.肺主通调水道,其标在肺)。郑老^[3]认为“因肾、因肺、因脾”充分阐述了人体的水谷精微来源、化生、封藏以及输布。由此可见肾病综合征的主证“水肿”与脾肾两脏的关系密切,脾虚输布功能障碍,无以制水,肾阳虚激发与温煦作用减弱,无以化水,故可见水

作者简介:周婵女(1997—),女,硕士研究生。研究方向:肾病的中医药防治。

* 通讯作者:王铁良(1940—),男,教授,博士生导师。

肿,水肿日久,水湿困脾,水为阴邪抑制肾阳的升化,遏制其温煦功能,恶性循环,导致脾肾两脏功能严重减弱或消失,累及全身。

2 临床研究

2.1 中药组方 真武汤^[4]出自中医经典《伤寒论》,具有温阳利水的功效,主要用于脾肾阳虚型水肿。真武汤中附子温阳祛寒,上中下温补心脾肾;茯苓、白术健脾利水,助附子温阳利水之功;佐辛温之生姜以散水气;最后配伍白芍行气利水、敛阴和营。现代医学研究表明真武汤成分有利尿、减轻肾脏炎症反应、改善肾功能、降血脂等药理作用。真武汤适用于肾病多个方面,在肾病综合征治疗中显现出独特的优势。黄刚等^[5]认为脾肾阳虚,病久入络,常常会伴有血虚血瘀。故运用真武汤合当归芍药散,温补脾肾,化气利水,补血活血,不仅改善症状,减轻药物不良反应,还提高生活质量。覃柳菊^[6]认为出现高度浮肿及四肢不温等症状是因为脾虚不能制水,引起肾阳不足,温煦功能失司不化水湿。故选用《伤寒论》中温阳利水的经典名方真武汤及《中藏经》中健脾化湿、理气消肿方五皮饮合用,在此方基础上加用黄芪,降低尿蛋白水平,减轻水肿,提高临床疗效。张林等^[7]认为脾肾阳虚,阳气无以生发,水湿内生是 NS 的主要病机,故采用真武汤加味联合西药温脾利水,降低病理指标水平,缓解临床症状。梁春玲^[8]、滕玉霞^[9]等研究也发现真武汤可改善相关指标,保护肾脏结构与功能。刘瑞琪等^[10]查阅各类文献,总结出真武汤治疗肾病综合征有独特的优势,不仅能减轻临床症状及血液高凝,还能改善肾脏内毒素蓄积,保护肾组织,恢复肾功能。笔者经查阅文献,发现温阳利水方(炮附子、泽泻、干姜、猪苓、茯苓、白术、党参、炙甘草、山茱萸)在肾病综合征脾肾阳虚型的治疗中运用较多。NS 患者由于血液浓缩及血脂水平升高容易造成高凝状态,杜超等^[11]运用温阳利水方温补脾肾,使气血正常运行,降低血液流变学指标水平,改善高凝状态,减轻肾脏损伤,加速康复。林小常等^[12]发现温阳利水方不仅能缓解水肿、畏寒肢冷、神疲等阳虚症状,还能降低血脂、肾功能指标水平,促进病情转归。张铎^[13]通过开展临床试验,发现温阳利水方可改善临床症状及肾功能。雷磊^[13]、蔡建盛^[14]、赵国秀^[15]等分析温阳利水方联合西药的中西医结合疗法,得出 NS 患者血脂和肾功能明显改善。由此可见,温阳利水方具有调节血脂、缓解症状、保护肾功能的作用,值得临床推广。黄百洋^[16]运用黄芪补脾益气,附子温阳散寒,再加益脾温中燥湿药与补肾温阳之品共奏健脾益肾、温阳散寒之效,芪附温阳补肾汤可有效改善临床症状,提高免疫功能,延缓病情损害肾功能。韩翼翔^[17]研究发现益气温阳补肾汤可改善实验室指标,提高免疫力及临床疗效,促进病情转归。何雨桦等^[18]方用参芪温阳强肾汤,健脾益肾、益气活血、利水消肿,有显著的临床效果,促进恢复肾功能。石君华^[19]同其学生马晓研究加味实脾饮,加味实脾饮是在严用和的实脾饮基础上进行加减,加用了活血行气等药物活血化瘀和行气温阳,使其温阳健脾、利水消肿的功效更加完整,从而增强降蛋白尿、调血脂、缓解症状的临床效果。郭杰伟^[20]通过研究发现实脾饮联合西药可提高临床疗效,改善病理指标,保护肾功能。肾病综合征的主要临床症状之一为高脂血症,靳锋教授^[21]认为 NS 在长期激素治疗后,会引起血脂水平紊乱,加重肾脏负担,进一步损害

肾功能。他认为 NS 合并血脂异常的主要病机为脾肾亏虚致血行不畅、瘀血停滞,其学生谷慧萱运用温肾健脾、通脉降浊之补肾降脂方治疗 NS 合并血脂异常,得出了补肾降脂方可有效降蛋白尿、升白蛋白和调节血脂的结论。

2.2 中成药 朱聪等^[22]通过研究 60 例脾肾阳虚型肾病综合征患者,对比口服益肾康胶囊与补肾胶囊的疗效,发现补肾胶囊能降尿白蛋白、改善高凝状态,减轻运用激素的不良反应,保护肾功能。李子男等^[23]观察具有补肾健脾、活血通络作用的益肾健脾丸治疗肾病综合征脾肾阳虚证,得出结论益肾健脾丸可以有效降低尿白蛋白和身体各项异常指标,还可以减轻激素带来的不良反应,促进病情转归。

2.3 中医药联合外治辅助治疗 根据辨证论治,除了可以选择常见的中医药治疗,其他传统的中医外治法治疗 NS 也有特色,包括针灸、中药贴敷、中药灌肠等作为辅助疗法在临床运用中都有不错反响。赵大鹏教授^[24]带领张媛媛同学采用中频脉冲电联合温阳利水方治疗,证实中频脉冲电疗法辅助温阳利水方能改善 NS 患者实验室指标,减轻症状,提高疗效,且此疗法运用过程中无不良反应。彭红萍^[25]运用复肾散进行艾灸和穴位贴敷,观察症状、临床指标,发现复肾散可明显降低尿蛋白水平,提高白蛋白水平,显著减轻水肿。且复肾散是通过外治法,能避免胃肠道的不良反应,这对不愿服药的患者来说是一个不错的选择。陈福聪等^[26]研究温补脾肾法联合雷火灸灸水道、关元、中脘穴对 NS 患者体内激素受体水平的影响,发现通过雷火灸产生的热力辅助汤药,可提高调节身体机能,增强机体对治疗的敏感性,促使病情转归。

2.4 名医临证经验 阎晓萍^[27]教授认为脾阳不足,影响水液代谢,导致肾失温煦出现脾肾阳虚,阎教授一般采用芪苈异功汤及黄芪桂枝五物汤加减调理脾胃,恢复功能,以后天之本滋养先天之本。程锦国^[28]教授认为肾病综合征的病机为脾肾阳虚、浊毒内蕴,秉着五脏之治,予以本病温肾助阳、化气行水,兼顾湿、瘀、痰、毒等实邪,使用峻药(大黄、附子等),辨证配伍药对,临床效果确切。刘旭生^[29]教授认为脾肾阳气不足是肾病综合征的病机之要,在治疗方面应补脾益肾、利水消肿,自创补脾益肾方(黄芪、何首乌、菟丝子、淫羊藿、党参、白术、淮山、茯苓)。隋淑梅教授^[30]主张脾肾阳虚型肾病综合征临床应以温补脾肾为主,使脾气得升,脾主运化和肾主封藏的功能恢复,从而减少蛋白的流失,降低尿蛋白水平。常用熟地、山萸肉等温肾补阳之品,若伴严重水肿,则可加用利水消肿药物如茯苓、猪苓等。吾师王铁良教授惯用东垣中满分清汤化裁治疗肾病综合征脾肾阳虚型水肿,王老集泻心、六君、四茯、二陈、平胃于一方,能行气健脾、利水消肿而恢复肾阳,若水肿明显,方中加用焦槟片、大毛、冬瓜皮以加强行气利水消肿的作用。

3 小结与讨论

肾病综合征是肾小球疾病引起的一个临床综合征,肾病综合征的病理改变关键是肾小球毛细血管壁的损伤,血浆蛋白滤过增加,大量蛋白尿形成。长期的蛋白尿意味着血浆蛋白的不断流失,造成低蛋白血症,引起水肿。低蛋白血症刺激肝脏脂肪蛋白合成,影响血脂水平,形成高脂血症。肾病综合征归属于中

医的“水肿”范畴,水肿一般是由于脾肾阳虚造成的。脾主运化,运化水饮,水液的输布需经过脾气的激发与推动布散于全身,脾虚致脾失健运,则会导致水液输布障碍,而见水肿。肾主藏精、主水。肾为封藏之本,肾中精微物质的疏泄是依靠肾阴与肾阳。肾阳虚衰,肾中精微物质泄漏,肾病综合征患者会出现大量蛋白尿及低蛋白血症。肾阳减弱,推动、温煦作用减退可致水液不化,而见水肿。

治疗上,西医已经形成了规范的方式,一般治疗主要通过休息和饮食;对症治疗主要是利尿、降尿蛋白、调血脂;最关键糖皮质激素与免疫抑制剂的治疗。激素效果好,但是肾病综合征的病理类型多种,有激素抵抗型如膜性肾病,且激素及免疫抑制剂长期使用会对机体产生严重不良反应,所以西医治疗仍存在一定局限性。而中医通过辨证论治,以补肾健脾、利水消肿为治则治疗脾肾阳虚型肾病综合征,从脾肾两脏入手,根据实邪随症加减。目前,中医药在肾病综合征的治疗中发挥了独特的优势,中医药治疗不仅能有效减轻临床症状,改善实验室指标,延缓病情进展,而且对于使用激素的患者还能减缓激素带来的不良反应。还有一点,肾病综合征的病理类型繁多,一般需要肾脏活检才能确诊,且肾脏活检是有创性的检查,大多数患者无法接受。而中医药特色诊疗辨证论治,则可以避免肾脏活检直接治疗。不仅提高了治疗效果,还为患者减轻生活及心理负担,深受广大患者欢迎。但中医药治疗脾肾阳虚型肾病综合征也存在一些问题,如目前还未有统一的诊断标准、临床实验研究比较缺乏等。如今中西医结合治疗是较好的选择,可以利用现代研究探究中医机制,充分发挥中医药的优势,不断探索,相信会有一日中医药可单挑大梁,成为医学史上的主流,提高生活质量。

参考文献

- [1]杜超,李颖璐,李骥.温阳利水汤治疗对脾肾阳虚型原发性肾病综合征患者临床疗效观察[J].实用医院临床杂志,2021,18(6):59—62.
- [2]雷蕾,熊维建,郑新,等.国医大师郑新“肾病三因论”治疗肾病综合征浅析[J].中华中医药杂志,2020,35(2):709—710.
- [3]李福生,王茂泓.从“伏邪”论治肾病综合征[J].中华中医药杂志,2017,32(3):1092—1094.
- [4]耿芳,忽星歌,姜晨.真武汤在慢性肾脏病中临床及实验研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2021,23(4):213—216.
- [5]黄刚,叶一萍.真武汤合当归芍药散治疗原发性肾病综合征的疗效观察[J].中华中医药学刊,2017,35(2):488—491.
- [6]覃柳菊.中西医结合治疗脾肾阳虚型小儿肾病综合征 30 例临床观察[J].湖南中医杂志,2017,33(8):81—82.
- [7]张林,王喜红,等.加味真武汤联合西药治疗原发性肾病综合征脾肾阳虚证临床观察[J].河南中医,2021,41(9):1320—1324.
- [8]梁春玲,周玖瑶,周园,等.真武汤对渗透泵恒释 ADR 肾病综合征大鼠的干预作用[J].中国实验方剂学杂志,2013,19(6):215—219.
- [9]滕玉霞,于思明.真武汤对肾病综合征模型大鼠 HMGB1/Beclin-1 信号通路影响及机制研究[J].中国中西医结合肾病杂志,2020,21(5):388—391+472.
- [10]刘瑞琪,陈博知.真武汤治疗肾脏病的研究进展[J].内蒙古中医药,2019,38(6):158—160.
- [11]林小常,符斌,曾盛.温阳利水方治疗脾肾阳虚型肾病综合征的临床效果[J].智慧健康,2021,7(28):165—167.
- [12]张铎.温阳利水方治疗脾肾阳虚型肾病综合征临床观察[J].光明中医,2021,36(2):225—226.
- [13]雷磊.温阳利水汤联合环磷酰胺及醋酸泼尼松片治疗脾肾阳虚型原发性肾病综合征[J].河南医学研究,2019,28(21):3960—3962.
- [14]蔡建盛,许志建,严淑珍.温阳利水汤联合西医治疗脾肾阳虚型原发性肾病综合征的临床效果分析[J].中外医学研究,2019,17(1):153—154.
- [15]赵国秀,马鸿斌,魏锦慧.温阳利水汤联合西医治疗脾肾阳虚型原发性肾病综合征疗效观察[J].河北中医,2017,39(10):1526—1530.
- [16]黄百洋.芪附温阳补肾汤治疗脾肾阳虚型肾病综合征 55 例[J].浙江中医杂志,2021,56(10):729.
- [17]韩翼翔.益气温阳补肾汤治疗肾病综合征 40 例临床观察[J].湖南中医杂志,2020,36(6):37—39.
- [18]何雨桦,陈宁.参芪温阳强肾汤治疗原发性肾病综合征脾肾阳虚证 52 例[J].浙江中医杂志,2021,56(2):107.
- [19]马晓.加味实脾饮治疗脾肾阳虚型肾病综合征的临床观察[D].武汉:湖北中医药大学,2020.
- [20]郭伟杰.实脾饮加减联合西药治疗原发性肾病综合征脾肾阳虚证的临床疗效观察[J].黑龙江中医药,2021,50(1):10—11.
- [21]谷慧莹.补肾降脂方治疗脾肾阳虚型肾病综合征合并血脂异常的临床观察[D].兰州:甘肃中医药大学,2020.
- [22]朱聪,孙莹,高峰,等.补肾胶囊治疗脾肾阳虚型肾病综合征[J].长春中医药大学学报,2014,30(5):901—902.
- [23]李子男,祝领旗,陈丽丽,等.益肾健脾丸治疗肾病综合征(脾肾阳虚型)的临床研究[J].智慧健康,2020,6(18):178—179.
- [24]张媛媛.温阳利水方联合中频脉冲电治疗肾病综合征脾肾阳虚型临床观察[D].哈尔滨:黑龙江中医药大学,2020.
- [25]彭红萍.复肾散外用治疗脾肾阳虚型原发性肾病综合征临床观察[J].光明中医,2021,36(13):2121—2124.
- [26]陈福聪,魏涛.雷火灸联合温补脾肾法治疗原发性肾病综合征脾肾阳虚证的疗效观察[J].中医外治杂志,2021,30(2):38—39.
- [27]成晓萍,程红卫,赵田,等.阎晓萍从脾胃论治肾病综合征的经验总结[J].临床医学研究与实践,2021,6(21):19—21.
- [28]陈念昭,王峰,袁拯忠,等.程锦国治疗肾病综合征经验探析[J].浙江中医杂志,2021,56(09):632—634.
- [29]赵威,华俏丽,刘旭生.刘旭生教授治疗肾病综合征经验[J].中国中西医结合肾病杂志,2018,19(11):941—943.
- [30]王新伟,米娜,隋淑梅.隋淑梅教授辨证治疗肾病综合征经验[J].中国中西医结合肾病杂志,2017,18(12):1097—1099.